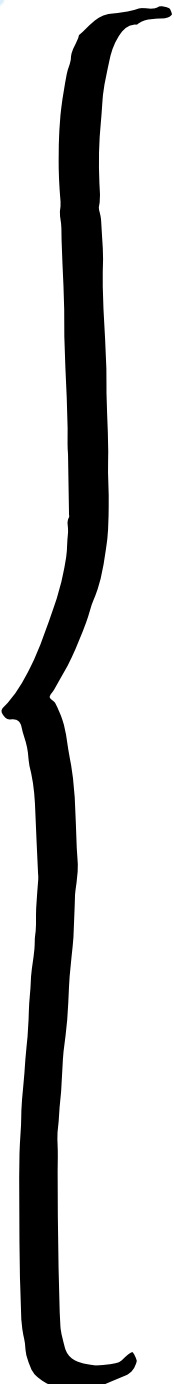


ENTREGABLE nº2



GRUPO 11

INFORMACIÓN PERSONAL

- 
- Datos del paciente: Varón de 39 años, iniciales UCC, procedente de la ciudad de Arequipa.
 - Estado actual: Ingresado para programa de rehabilitación integral.
 - Objetivos terapéuticos:
 - Lograr locomoción independiente en silla de ruedas.
 - Reeducación esfinteriana.
 - Adaptación en los ámbitos psicológico, laboral y sexual.

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIAMIENTO

- **Condición económica:** El registro general indica que el paciente presenta dependencia económica.
- **Cobertura médica:** La atención hospitalaria inicial fue manejada y cubierta por el Hospital de EsSalud de Arequipa.
- **Alcance de cobertura:** Incluyó la estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y todas las intervenciones quirúrgicas mayores



DIAGNÓSTICO DE INGRESO

(CIE-10): Traumatismo de la médula espinal NN T12 AIS "A" por aplastamiento (T09.3/W20.9).

- Motivo de ingreso a INR: Rehabilitación integral
- Locomoción independiente en silla de ruedas, se evaluará posibilidad de bipedestación y marcha con ayudas biomecánicas según evolución y posterior a evaluación por traumatología.
- Independencia en actividades de vida diaria.
- Reeducción esfinteriana.
- Prevención de complicaciones.
- Adaptación psicológica. Orientación sexual.
- Orientación laboral.

HISTORIAL QUIRÚRGICO, COMPLICACIONES Y PRONÓSTICO

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

- Rafia de diafragma por rotura diafragmática (08.11.2024).
- Fijación transpedicular de columna dorsolumbar de T11-T12 a L2-L3 (23.11.2024).
- Osteosíntesis en la tibia proximal derecha (20.12.2024).

COMPLICACIONES INTRAHOSPITALARIAS

Neumonía asociada a ventilador mecánico, infecciones urinarias recurrentes y úlceras por presión (talón y zona peronea).

PROBLEMAS ACTIVOS:

Zona de presión por osteosíntesis y defecto de consolidación. El miembro inferior derecho presenta el mayor riesgo mecánico por antecedente de fractura.

PRONÓSTICO:

Neurológico clasificado como malo; pronóstico de rehabilitación considerado bueno.

AFECCIÓN DE LA PIEL

ESTADO ACTUAL

Sin presencia de
úlceras por presión
(UPP) activas en la
evaluación de junio de
2026

ANTECEDENTES

Registro de UPP en
talón y zona peronea

CICATRICES

QUIRÚRGICAS

Presencia de cicatrices
por fijación quirúrgica
dorsolumbar ,
osteosíntesis de tibia
proximal derecha y
rafia diafragmática

SENSIBILIDAD, HABLA Y COGNICIÓN

- **Lenguaje expresivo y comprensivo adecuados**
- **Fluidez y articulación conservadas**
- **No requiere el uso de sistemas alternativos o aumentativos de comunicación (CAA)**

- **Paciente lúcido y orientado en tiempo, espacio y persona.**
- **Conducta y funciones cognitivas clasificadas como conservadas en el examen neurológico básico.**

DESEMPEÑO FUNCIONAL, DE HABILIDADES Y TAREAS

- Principal asistente su esposa
- Requiere ayuda en el control de esfínteres e higiene mayor.
- No presenta problemas al comer y tiene bajo riesgo de aspiración
- Sin problemas para realizar tareas que impliquen el tercio superior



Comer



Higiene Personal



Vestirse



Dormir/ Descanso



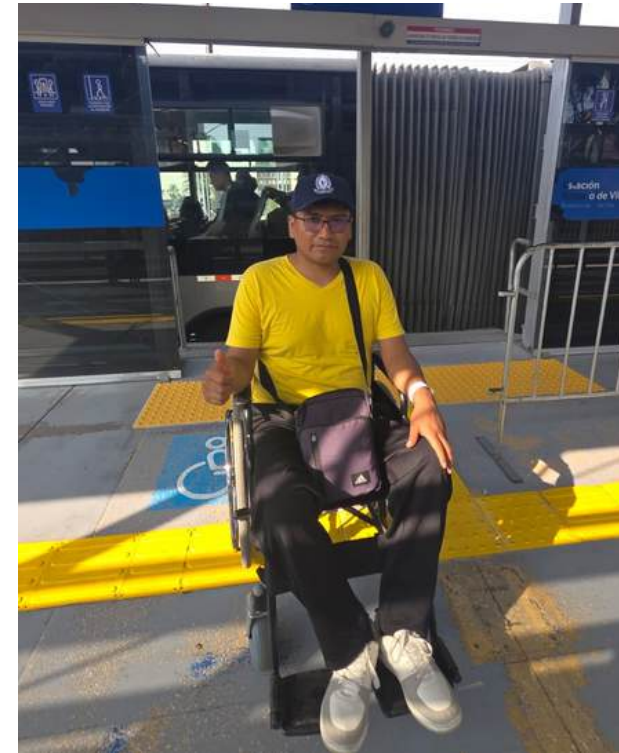
Control de
esfínteres



Movilidad
Funcional

MOVILIDAD PERSONAL

Para tramos largos utiliza una silla de ruedas (tipo activa), sin presentar problemas para movilizarse por cuenta propia..



Para tramos cortos o eventos sociales, podría usar soportes largos con banda pélvica para reeducar la marcha, utilizando un andador para iniciar una marcha recíproca. Anteriormente hacia uso de UTP, ahora restringida debido a una fractura de tibia proximal derecha



TRANSPORTE COMUNITARIO Y MOVILIDAD

El paciente acude actualmente en una silla de ruedas prestada en regular estado de conservación (se prevé la entrega de la silla propia en 20 días). Requiere la asistencia de una tercera persona para traslados y actividades de higiene mayor, debido a su nivel motor T12 y dependencia económica.



Debido a la dependencia de dispositivos de apoyo, se requiere evaluar la accesibilidad en vehículos comunitarios, asegurando rampas o adaptaciones mecánicas para asegurar traslados seguros desde Arequipa hacia el centro de rehabilitación.

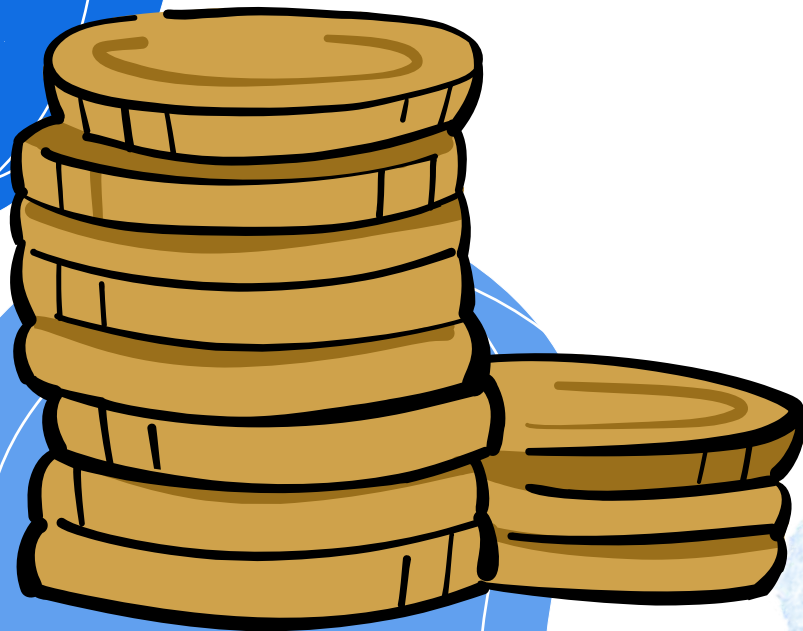


ENTORNOS, DINÁMICA SOCIAL Y VOCACIONAL

Situación de Vida y Entorno:
Procede de Arequipa, presenta dependencia económica y requiere enfoque integral para su adaptación psicológica y soporte familiar

Vocación y Empleo: Dentro de los objetivos principales de ingreso a la institución se contempla la orientación laboral y la reincorporación progresiva a sus actividades productivas.

Condición Cognitiva: El paciente se encuentra lúcido, orientado en espacio, persona y tiempo, con conducta y cognición conservadas, lo cual favorece favorablemente los procesos de aprendizaje y readaptación ambiental.



ENTORNOS, DINÁMICA SOCIAL Y VOCACIONAL

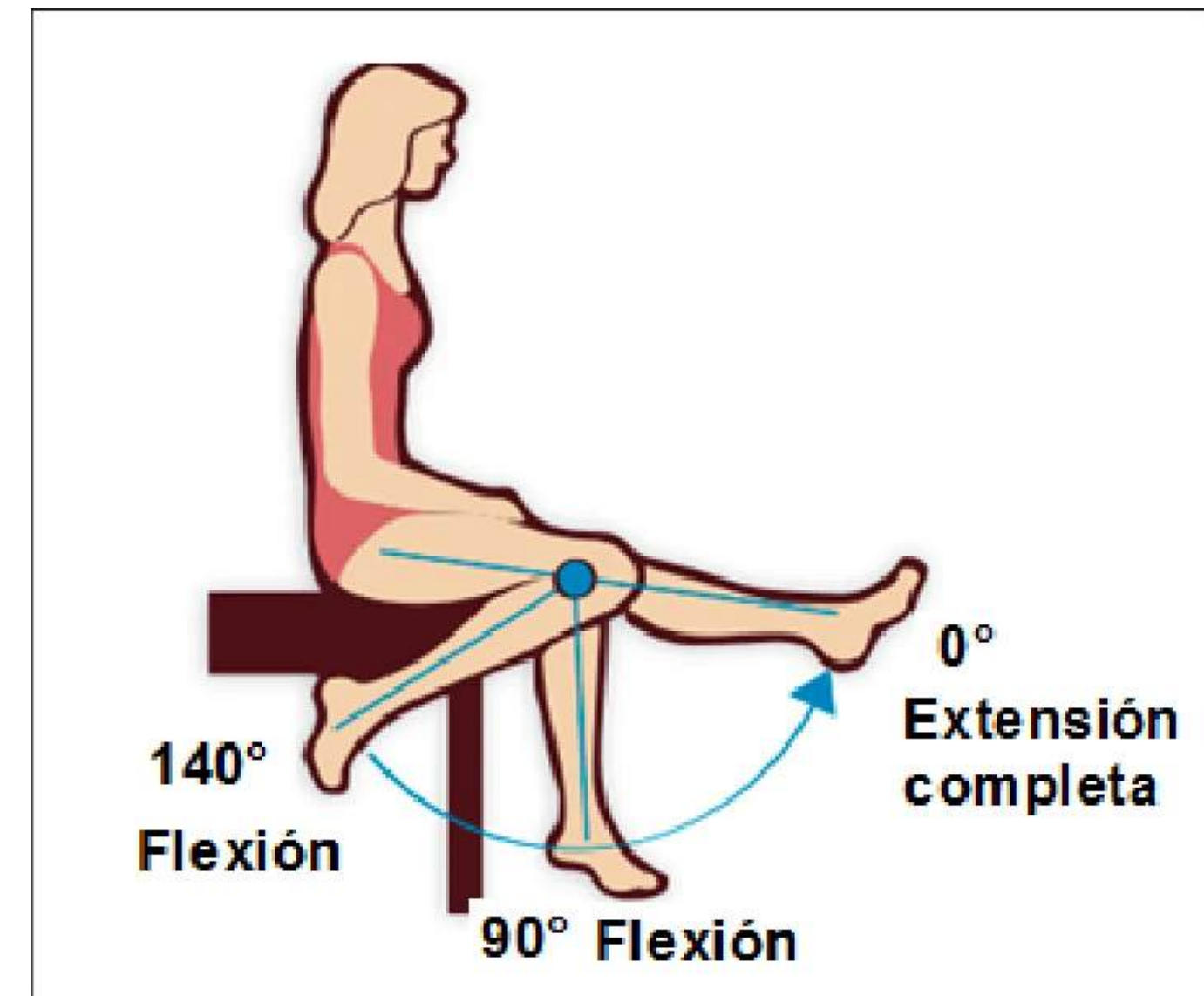
Antes del accidente, el paciente se desempeñaba como ingeniero ambiental, y actualmente depende de su esposa, quien es su cuidadora principal. Adicionalmente, se registra que el paciente presenta dependencia económica, lo cual ahora cobra más sentido al saber que es su esposa quien cumple ese rol de soporte tanto económico como de cuidado. En el examen físico especializado se documenta también que requiere asistencia de una persona para traslados e higiene mayor, y un SCIM esfinteriano bajo (vejiga: 15, intestino: 8), reflejando alta dependencia funcional en el manejo de esfínteres.



ESTADO NEUROMUSCULAR Y MUSCULOESQUELÉTICO



- El caso reporta un nivel neurológico motor/sensitivo T12 con ausencia S4-S5 (lesión completa, AIS A), reflejos osteotendinosos abolidos bilateralmente, sin Babinski ni clonus, y Beevor negativo.
- Musculoesqueléticamente, presenta restricción de flexión de rodilla derecha $>90^\circ$ con crepitación, secuela de la osteosíntesis por fractura de tibia proximal derecha.
- Esta es, de hecho, la lesión más limitante del paciente, por encima de la lesión neurológica en cuanto a restricción funcional.



EQUIPOS DE APOYO

- No se cuenta con suficiente información sobre el uso anterior de otros equipos de apoyo para la movilidad o las actividades diarias, ni sobre las dificultades que pudo haber tenido con ellos.

- Actualmente, el paciente utiliza una silla de ruedas para desplazarse en tramos largos. Se encuentra en solicitud de un soporte largo con banda pélvica.
- Debido a que su principal limitación está relacionada con la lesión de la pierna, se espera que este soporte pueda ayudarlo a desplazarse y favorecer una mejor marcha y condición funcional.

RESUMEN

- Paciente masculino de 39 años
- Diagnóstico de traumatismo vertebromedular con nivel neurológico T12 AIS A, paraplejia completa y pérdida sensitiva de L1 a S5. restricción mecánica de flexión de la rodilla derecha.
- Funciones cognitivas conservadas, lúcido y orientado en tiempo, espacio y persona. Presenta habla, comunicación, visión, audición y deglución normales. Conserva fuerza motora y coordinación motora en miembros superiores y tronco superior.
- Alimentación independiente, manejo asistido de cateterismo vesical y evacuación intestinal, y asistencia en el aseo personal. Su esposa desempeña la labor como cuidadora principal.
- Entorno domiciliario no presenta las adaptaciones adecuadas. Se desplaza con una silla de ruedas estándar, con solicitud de tipo activa, para trayectos largos y autonomía. Se realizó una solicitud de soportes largos con banda pélvica en combinación con un andador para la bipedestación y marcha recíproca en tramos cortos.

The background features a white canvas with decorative elements. In the top-left corner, there is a light blue watercolor splash. The top-right corner is adorned with a solid blue abstract shape. The bottom-left corner contains a solid blue abstract shape, and the bottom-right corner features a light blue watercolor splash. The text is centered in a bold, dark blue, sans-serif font.

**¡MUCHAS
GRACIAS!**